

CAPÍTULO 11.14

Síndrome Nefrótico

PERFIL EUNACOM 1.05.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Definición de la Nefritis Intersticial

La **Nefritis Intersticial**, técnicamente denominada **Nefritis Túbulo-Intersticial (NTI)**, es un proceso inflamatorio que afecta primordialmente al intersticio renal y a los túbulos. Es una causa importante de **Insuficiencia Renal Aguda** de origen renal (parenquimatoso). Es fundamental realizar el diagnóstico diferencial con las glomerulonefritis. A diferencia de estas últimas, en la nefritis intersticial los **glomérulos están preservados**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En la Nefritis Intersticial **no hay hematuria dismórfica** ni cilindros hemáticos, ya que el daño no es glomerular. Si encuentras hematuria dismórfica, debes orientar el diagnóstico hacia una **Glomerulonefritis**.

Etiología: ¿Qué causa la inflamación?

La causa más frecuente de nefritis intersticial es la reacción de hipersensibilidad a medicamentos, aunque existen otros gatillantes que deben ser considerados en el estudio clínico.

TABLA 11.14.1: CATEGORÍA VS EJEMPLOS COMUNES

CATEGORÍA	EJEMPLOS COMUNES
Fármacos (70-75%)	AINes , Antibióticos (Beta-lactámicos , penicilinas, cefalosporinas), Sulfonamidas, Diuréticos, Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP).
Infecciones	Puede ser por invasión directa del parénquima o como respuesta inmunológica sistémica (ej. Pielonefritis, Legionella, Leptospira, CMV).
Enfermedades Autoinmunes	Síndrome de Sjögren (muy importante), Lupus Eritematoso Sistémico , Sarcoidosis, Vasculitis.
Idiopáticas	Síndrome de TINU (Nefritis Intersticial con Uveítis).

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología se basa en una **reacción de hipersensibilidad tipo IV** (mediada por células T) o tipo I. El fármaco actúa como un hapteno que se une a la membrana basal tubular, desencadenando una respuesta inflamatoria linfocítica y eosinofílica que destruye el tejido intersticial.

Clínica y Presentación Típica

El paciente suele debutar con un deterioro agudo de la función renal (elevación de creatinina) tras la exposición a un fármaco (días o semanas después).

La Tríada Clásica

Aunque no siempre está presente en su totalidad, la sospecha diagnóstica aumenta significativamente ante la presencia de: 1. **Fiebre**. 2. **Rash** (exantema cutáneo maculopapular). 3. **Eosinofilia** periférica.

Hallazgos en el Examen de Orina

- **Proteinuria**: Generalmente leve o moderada (no de rango nefrótico, a menos que sea por AINes que también causen cambios mínimos). - **Leucocituria**: Presencia de glóbulos blancos en el sedimento. - **Eosinofilia**: La presencia de eosinófilos en la orina es un hallazgo muy sugerente, aunque su ausencia no descarta el cuadro.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, asocia siempre la combinación de **Falla Renal + Rash + Eosinofilia** con Nefritis Intersticial por fármacos (frecuentemente tras usar penicilinas o AINes).

Síndromes Especiales Relacionados

Síndrome de DRESS

El síndrome de **DRESS** (*Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms*) es una reacción severa a drogas que incluye: - Exantema cutáneo extenso. - Eosinofilia marcada. - Linfocitosis atípica. - Compromiso de órganos internos (siendo el riñón y el hígado los más afectados). Es una urgencia dermatológica y nefrológica que requiere hospitalización inmediata.

Síndrome Óculo-Renal (TINU)

Es una variante idiopática y autoinmune poco frecuente. Se caracteriza por la combinación de: - **Nefritis Túbulo-Intersticial**. - **Uveítis** anterior bilateral. Debe sospecharse en pacientes con falla renal de origen desconocido que presentan inflamación ocular.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante la **Biopsia Renal**.

- **Hallazgos histológicos**: Infiltrado inflamatorio en el intersticio (linfocitos, células plasmáticas y frecuentemente eosinófilos), edema intersticial y tubulitis (linfocitos invadiendo la pared de los túbulos).
- **Glomérulos**: Se observan normales o con cambios mínimos.

En la práctica clínica, muchas veces el diagnóstico es presuntivo basado en la relación temporal con el fármaco y la clínica sistémica.

Tratamiento

El manejo se basa en modular la respuesta inmune y eliminar el agente agresor.

- **Suspender la causa**: Retirar de forma inmediata el fármaco sospechoso o tratar la infección subyacente.
- **Corticoides**: Se utilizan para acelerar la recuperación funcional y disminuir el riesgo de fibrosis intersticial crónica. (Ej. Prednisona 1 mg/kg/día).
- **Tratamiento de la enfermedad de base**: Si es secundaria a **Síndrome de Sjögren** o Sarcoidosis, se debe optimizar el manejo de dichas patologías.

EUNACOM CRITERIOS

El tratamiento con **corticoides debe iniciarse ante la sola sospecha clínica fuerte**, sin esperar necesariamente los resultados de la biopsia renal. El retraso en el inicio de los corticoides se asocia a una menor recuperación de la función renal basal.

Resumen para el EUNACOM

- **Sospecha**: Paciente que inicia un fármaco nuevo (especialmente penicilinas o AINes) y desarrolla falla renal aguda, rash y fiebre. - **Laboratorio clave**: Elevación de creatinina + Eosinofilia + Eosinofilia. - **Diferencial**: No hay cilindros hemáticos (a diferencia de las GN) ni signos de hipovolemia (a diferencia de la falla prerenal). - **Conducta**: Suspender fármaco y considerar corticoides precozmente. **Insuficiencia Renal Aguda Enfermedad Renal Crónica Sepsis y Shock Séptico**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Niño de 6 años con edema generalizado, orinas espumosas, proteinuria de 5.2 g/día, albúmina sérica de 2.1 g/dL. Sedimento sin hematuria. Complemento y ANA normales. Creatinina normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Nefrótico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico: proteinuria mayor a 3 g/día + edema + hipoalbuminemia menor a 3.5 g/dL. En niños: mayor a 40 mg/m²/hora.
- Complicaciones principales: infecciones (pérdida de Ig/complemento) y trombosis (pérdida de proteínas anticoagulantes).
- Puro en niño = enfermedad de cambios mínimos: corticoides sin biopsia. Si no responde, biopsiar.
- Impuro, adulto o no responde a corticoides = biopsia renal obligatoria.
- Congénito (menor 3 meses): test genéticos primero, biopsia de entrada, tratamiento = trasplante renal.
- Manejo: IECA/ARA-2 para proteinuria, dieta normoproteica, furosemida para edema (cuidado prerrenal).
- Anticoagulación solo si trombosis confirmada, no profiláctica.
- Vacunar contra neumococo a todo paciente con síndrome nefrótico.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME NEFRÓTICO)**PREGUNTA 1**

Niño de 6 años con edema generalizado, orinas espumosas, proteinuria de 5.2 g/día, albúmina sérica de 2.1 g/dL. Sedimento sin hematuria. Complemento y ANA normales. Creatinina normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Biopsia renal urgente
- B)** Prednisona oral en dosis altas por 2-3 meses
- C)** IECA más dieta hipoproteica
- D)** Anticoagulación profiláctica
- E)** Test genéticos para síndrome nefrótico congénito

PREGUNTA 2

Adulto de 50 años con síndrome nefrótico puro (proteinuria 8 g/día, sin hematuria, complemento normal). ¿Cuál es la conducta?

- A)** Asumir enfermedad de cambios mínimos e iniciar corticoides
- B)** Biopsia renal para diagnóstico etiológico
- C)** Solo IECA y seguimiento
- D)** Albumina endovenosa como tratamiento definitivo
- E)** Observar 3 meses antes de decidir

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrótico congénito (diagnóstico en menor de 3 meses)?

- A)** Corticoides orales en dosis altas
- B)** IECA para disminuir proteinuria
- C)** Trasplante renal
- D)** Inmunosupresores (ciclofosfamida)
- E)** Diálisis peritoneal crónica

RESUMEN: SÍNDROME NEFRÓTICO

El síndrome nefrótico se diagnostica con proteinuria en rango nefrótico (mayor a 3 g/día o índice P/C mayor a 3; en niños mayor a 40 mg/m²/hora) más clínica: edema, hipoalbuminemia (menor a 3.5 g/dL), dislipidemia, lipiduria y orinas espumosas. Sus complicaciones principales son infecciones (pérdida de anticuerpos) y trombosis (pérdida de proteínas anticoagulantes), y evoluciona a IRC. Se clasifica en puro e impuro. Es impuro si tiene hematuria, hipertensión o falla renal. Si es puro en un niño, se asume enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoidea) y se trata con prednisona oral (60 mg/m² por 6 semanas) sin biopsia. Si es impuro, adulto, o no responde a corticoides, se biopsia. El síndrome nefrótico congénito (menor a 3 meses) requiere test genéticos y el tratamiento es trasplante renal. El manejo general incluye IECA/ARA-2 para reducir proteinuria (alternativa: diltiazem), dieta normoproteica, furosemda para edema (cuidado con prerrenal), vacunación contra neumococo, y anticoagulación solo si hay trombosis confirmada.